Établissement

Médecin

CONDUITE À TENIR — AS · AES · ÉDUCATEURS

Appeler le 15 : le bon message (SAED)

Préparer, dire et tracer l'appel au SAMU-Centre 15 : tout public (EHPAD, MAS, FAM, IME), de jour comme de nuit. Seuils : « Fiche 0 — Signes de gravité ».

URGENCE VITALE → APPEL 15 IMMÉDIAT · ne répond pas ou ne respire pas normalement : appeler tout de suite, haut-parleur, et faire les gestes que dicte le régulateur ; les mesures attendront.

1 · Avant d'appeler (1 minute)

- Je reste près de la personne, **téléphone en main**.
- Un collègue apporte le **DLU**, la liste des traitements, le dossier.
- **LAT, directives anticipées, fiche Urgence Pallia, PAI** : je les ai sous les yeux.
- Adresse, bâtiment, étage, chambre, numéro de rappel.

2 · Je rassemble les chiffres

- Conscience, respiration, couleur ; heure de début ; dernière heure où elle a été vue **normale**.
- Pouls, **TA aux deux bras**, SpO2, FR, température.
- **Glycémie capillaire systématique** (AS/AP).
- **Anticoagulant ou antiagrégant ?** (Kardégic, Plavix, Eliquis, Xarelto, AVK…).

Pendant l'appel, puis en attendant

- **Haut-parleur**, près de la personne : je fais les gestes demandés (PLS, RCP, DSA).
- Je garde la ligne libre ; je **rappelle le 15** si l'état change.
- La nuit : **porte ouverte**, lumières allumées, quelqu'un **accueille les secours**.
- DLU, traitements, LAT et PAI **prêts** à remettre ; une seule personne répond aux secours.

Je ne fais pas

- Raccrocher **sans l'accord du régulateur**.
- Accepter une consigne hors de mes compétences (injection, réglage de l'O2) : je dis ma fonction.
- Donner à boire, à manger ou un médicament non prévu en attendant les secours.
- Laisser la personne seule si personne ne peut rester à côté d'elle.

3 · Je parle : le message SAED, phrase par phrase

S et A : qui, quoi, quel terrain

- **S**ituation : « Je suis [nom, fonction] à [établissement, adresse]. J'appelle pour [nom, âge] qui [problème] depuis [heure]. »
- **A**ntécédents : « Il a [maladies, handicap, troubles de déglutition]. Traitement : [anticoagulant ?]. LAT : [oui/non]. »

É et D : mes constatations, ma demande

- **É**valuation : « Il [répond/ne répond pas], respire [normalement ?]. Pouls…, TA… aux 2 bras, SpO2…, T°…, glycémie… »
- **D**emande : « Je demande [un conseil, un médecin, une ambulance]. Mon numéro de rappel est… »
- Je **répète** la réponse du régulateur pour vérifier que j'ai bien compris.

Après l'appel : je trace

- Heure de l'appel, consignes et décision du 15, heure d'arrivée des secours, hôpital.
- Médicament conseillé par téléphone : l'IDE ou le médecin obtient l'**ordonnance écrite**.
- Je préviens l'IDE, le cadre d'astreinte, la famille selon la procédure (IME : parents).

La règle d'or

Je donne des faits et des chiffres, le régulateur décide. Je ne raccroche jamais sans son accord.

Fait à : …… Le : …… / …… / ……

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, SAED : un guide pour faciliter la communication entre professionnels de santé (2014) ; ASSURE IDF, fiche C (2023) ; ARS IDF/STARAQS, fiche 0 handicap (2023) ; Urg'ARA/ARS ARA, EHPUR, check-list avant appel (2025) ; OMéDIT Centre-Val de Loire, Urgences en EHPAD (2025) ; HAS, DLU (MAJ 29/04/2026).

Réf. DOTR-AS-SAED | Version 1.0 – 10/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature